ما الذي تعنيه أوراقك، وما الخطوة التالية؟

تقرير عربي للمناقشة مع طبيب المسالك البولية

القرار الأهم الآن

احصل على تقرير الخزعة الأصلي ونتيجة إعادة الاستئصال بتاريخ 6 أكتوبر 2026، ثم راجعهما مع الطبيب في الموعد الظاهر: 13 أكتوبر 2026، بعد تأكيده مع العيادة. الأوراق تصف ورما منخفض الدرجة، لكنها لا تثبت المرحلة أو فئة الخطورة.

ما يمكن إثباته من الملفات المرفقة

ملخص الخروج يذكر «ورما ظهاريا بوليا منخفض الدرجة»، وتحت خانة النتائج يذكر سرطانا حليميا ظهاريا بوليا منخفض الدرجة. سبب الدخول هو إعادة استئصال ورم المثانة عبر الإحليل. تاريخ الدخول 5 أكتوبر، والعملية والخروج 6 أكتوبر 2026. هذه معلومات من الملخص الطبي وليست قراءة لتقرير خزعة مستقل.

تاريخ الميلاد المسجل هو 1 يناير 1988، أي عمر يقارب 38 عاما. تاريخ الاستئصال الأول والعلاج السابق غير موجودين في الصور. لا تتضمن الصور نتيجة العينة الأخيرة أو وصف حجم الأورام وعددها أو وجود غزو للعضلة.

ماذا أفعل خلال الأيام القادمة؟

1. اطلب نسختي الخزعة وتقرير العمليتين، واسأل عن المرحلة والدرجة ووجود عضلة المثانة في العينة. هذه البيانات تحدد اختيار العلاج والمتابعة. [1، 2]

2. اطلب من الطبيب أن يكتب فئة الخطورة وخطة العلاج داخل المثانة إن لزم، وأن يحدد موعد أول منظار متابعة؛ المعتاد لسرطان المثانة غير الغازي للعضلة هو بعد نحو ثلاثة أشهر. [3]

3. لا يمكن تحديد نسبة شفاء أو نكس شخصية من هذه الصور والفيديو. انخفاض الدرجة علامة أفضل عادة، لكن الحكم يتوقف على المرحلة والتاريخ السابق. [4، 5]

علامات تستدعي رعاية عاجلة

توجه للطوارئ عند عدم القدرة على التبول، أو نزف غزير وخثرات كبيرة، أو ألم شديد متزايد، أو حرارة وقشعريرة مع شعور بالتوعك. لا تنتظر موعد المتابعة عند ظهورها. [6]

أعد هذا التقرير بمساعدة الذكاء الاصطناعي للتثقيف ومناقشة القرار مع الطبيب. لا يعد تقرير خزعة أو وصفة علاج. البحث محدث حتى 9 أكتوبر 2026.

مراجعة الصور والفيديو وحدود الاستنتاج

الفصل بين المعلومات المكتوبة والمشاهدة البصرية

الملف	المعلومات المقروءة
1.jpg	تشخيص منخفض الدرجة؛ دخول لإعادة الاستئصال؛ دخول 5 أكتوبر وعملية 6 أكتوبر. لا توجد صفحة خزعة تفصيلية.
2.jpg	استئصال ورم المثانة عبر الإحليل بتاريخ 6 أكتوبر؛ باراسيتامول عند الحاجة ضمن أدوية الخروج. لا يظهر توثيق علاج داخل المثانة.
3.jpg	تعليمات النشاط والتعافي؛ موعد متابعة يبدو واضحا بتاريخ 13 أكتوبر 2026. بعض النصوص باهتة.
4.jpg	توثيق تعليمات الخروج ووسيلة التواصل مع المستشفى؛ لا تضيف تفاصيل لمرحلة الورم.
surgy.mp4	تصوير هاتف لشاشة منظار، مدته 5 دقائق و25 ثانية تقريبا، بدقة 478 × 850 بكسل.

ما الذي راجعته في الفيديو؟

راجعت 66 لقطة ثابتة موزعة كل خمس ثوان، مع لقطة قرب النهاية، إضافة إلى 24 لقطة موزعة أولية. هذه مراجعة لعينات زمنية تغطي امتداد المقطع، وليست مشاهدة متصلة لكل إطار أو تقييما كاملا للعملية.

تظهر أداة ذات حلقة معدنية ضمن المنظار، ومشاهد قطع أو كي للنسيج مع احمرار ودم وتغيرات في سطح موضع الإجراء. هذه مشاهد متوافقة مع إجراء الاستئصال المذكور؛ لا تسمح بتحديد درجة الورم أو عمق غزوه أو إثبات وجود العضلة في العينة.

ما لا يمكن للفيديو إثباته

لا أستنتج منه أن الورم أزيل بالكامل، أو أن المثانة خالية من أورام أخرى، أو أن النزف طبيعي أو غير طبيعي، أو أن السرطان سطحي أو منتشر. تحديد ذلك يحتاج تقرير الجراح والخزعة والفحوص المناسبة. [7]

غياب توثيق الدواء أو الأشعة من صور الخروج لا يثبت أنها لم تعط أو لم تجر. توجد خانة تاريخ منفردة في الصفحة الثانية لا تطابق تسلسل أكتوبر؛ استخدم تاريخ العملية الصريح والمتكرر.

فهم الدرجة والمرحلة، وبيانات الخزعة المطلوبة

«منخفض الدرجة» لا يساوي تلقائيا «منخفض الخطورة»

الدرجة تصف شكل الخلايا ومدى عدوانيتها تحت المجهر، بينما المرحلة تصف عمق امتداد الورم. قد يعود الورم منخفض الدرجة داخل المثانة بعد العلاج؛ وإذا ثبت أنه Ta منخفض الدرجة، فإن تطوره إلى غزو العضلة أقل شيوعا من الأورام عالية الدرجة. هذه ملاحظة عامة وليست تقديرا شخصيا لحالتك. [4، 8]

المصطلح	معناه المختصر
Ta	ورم حليمي لم يغز النسيج الضام تحت البطانة.
T1	وصل إلى النسيج الضام تحت البطانة، ولم يغز العضلة.
T2	غزا عضلة المثانة؛ يتطلب مسار تقييم وعلاج مختلفا.
CIS / Tis	ورم مسطح داخل البطانة، عالي الدرجة، وقد يصاحب ورما حليميا.

المصدر للتعريفات: المعهد الوطني للسرطان. [8]

اطلب هذه البنود في تقرير المختبر

- التشخيص الدقيق والدرجة، والمرحلة المرضية إن أمكن تحديدها: Ta أو T1 أو T2.
- وجود عضلة المثانة الحقيقية في العينة، وهل هي خالية من الورم أم مصابة.
- وجود CIS أو غزو للأوعية الدموية أو اللمفاوية، أو نوع نسيجي خاص.
- وصف عينة قاعدة الورم وأي صعوبة في التقييم بسبب أثر الكي أو نقص العينة. [1]

أسئلة خاصة بإعادة الاستئصال

هل كانت العملية لإكمال استئصال سابق، أو للحصول على عينة أعمق، أو بسبب مرحلة T1، أو لعلاج ورم عاد لاحقا؟ كلمة «إعادة الاستئصال» في ورقة الخروج لا تثبت وحدها حدوث نكس.

إذا لم يظهر ورم متبق في العينة الجديدة، فهذه نتيجة مفيدة، لكنها لا تلغي خطورة الورم الأصلي أو الحاجة للمتابعة. لذلك يجب تفسير التقريرين معا. [2]

تقديري الحالي للحالة

الوصف المكتوب يرجح ورما منخفض الدرجة. لا توجد معلومات كافية لتأكيد Ta أو غياب غزو العضلة أو فئة الخطورة، ولا توجد في الملفات المقدمة نتيجة تثبت الانتشار خارج المثانة. غياب هذه النتيجة لا يستبعد الانتشار من دون تقييم مناسب.

كيف يتغير العلاج بحسب النتيجة؟

خيارات مشروطة؛ يختار الطبيب المسار بعد اكتمال البيانات

إذا ثبت ورم Ta منخفض الدرجة ومنخفض الخطورة

من أمثلته ورم أولي صغير منفرد دون CIS. العلاج المعتاد هو الاستئصال مع علاج موضعي حول وقت العملية حسب ملاءمته، ثم المراقبة بالمنظار. لا يلزم عادة برنامج BCG للحالات منخفضة الخطورة. [5]

إذا كان منخفض الدرجة لكنه متكرر أو متعدد أو أكبر حجما

قد تصنف الحالة متوسطة الخطورة. يناقش الطبيب علاجا كيميائيا داخل المثانة، مثل ميتومايسين أو جيمسيتابين، أو BCG لمدة سنة في بعض الحالات. في EAU 2026 يعد العلاج الكيميائي خيارا أوليا مناسبا لكثير من حالات الخطورة المتوسطة. [5، 9]

إذا ظهر ارتفاع الدرجة أو CIS أو غزو مهم

تعاد مراجعة فئة الخطورة. T1 يحتاج استكمال التقييم، ويصبح BCG مع الصيانة من الخيارات الرئيسية في حالات الخطورة العالية؛ تناقش إزالة المثانة في حالات مختارة عالية أو عالية جدا. إذا ثبت T2 فتلزم مراجعة فريق أورام متعدد التخصصات لتخطيط علاج غزو العضلة. [9، 4]

هل يلزم استئصال آخر؟

إعادة الاستئصال توصى بها عند عدم اكتمال الاستئصال، أو T1، أو غياب العضلة من العينة مع استثناءات تشمل منخفض الدرجة. عند الحاجة تجرى عادة خلال أسبوعين إلى ستة أسابيع من الاستئصال الأول. لا يمكن تقرير Ta حاجتك لعملية ثالثة دون الخزعتين وتقرير الجراح. [1]

فرق مهم بين الجرعة الفورية والكورس اللاحق

الجرعة الوقائية الفورية داخل المثانة تعطى خلال 24 ساعة من الاستئصال عندما تكون آمنة. بما أن عملية 6 أكتوبر مضى عليها ثلاثة أيام، لا تستبدل الآن بجرعة متأخرة تسمى «فورية». أما برنامج العلاج اللاحق فله هدف وتوقيت مختلفان. [9]

تمنع الجرعة الفورية عند الاشتباه بثقب المثانة أو نزف يحتاج غسلها. ويؤجل BCG في أول أسبوعين بعد الاستئصال، وعند الدم الظاهر أو التهاب البول المصحوب بأعراض أو القسطرة الراضة. يحدد الطبيب موعد البدء بعد التعافي. [9]

أحدث الأدلة الأقرب إلى وصف حالتك

تحديثات 2025 و2026 مع دراسة أساسية ما زالت تؤثر في القرار

1. تحديث AUA/SUO في سبتمبر 2026

أعلنت الجمعية الأمريكية تحديثا في 3 سبتمبر 2026، ونشرت مقالة التحديث في مجلة المسالك. أبرز الإضافات خيارات للأورام منخفضة الدرجة المتكررة: المراقبة النشطة، والعلاج في العيادة، والإزالة الدوائية للورم لدى مرضى مختارين. الاختيار يعتمد على تأكيد التشخيص وخطة متابعة موثوقة. [10، 11]

2. ميتومايسين بصيغة هلامية: Zusduri / UGN-102

وافقت FDA عليه في 12 يونيو 2025 للأورام غير الغازية للعضلة، منخفضة الدرجة، متوسطة الخطورة والمتكررة. هو تركيب خاص يستخدم لإزالة الورم دوائيا عبر المثانة، ويختلف عن محلول الميتومايسين التقليدي والجرعة الوقائية بعد الجراحة. [12]

في تحليل FDA لدراسة ENVISION، حقق 78% من 223 مريضا قابلا لتقييم الاستجابة اختفاء كاملا ظاهرا للورم بعد ثلاثة أشهر؛ بقي 79% من المستجيبين في استجابة لمدة 12 شهرا على الأقل. قد تحدث حرقة والتهاب بول ودم في البول وتغيرات مخبرية. [12]

تحليل متابعة منشور في 2026 شمل 240 مريضا: استجاب 191، أي 80%، بعد ثلاثة أشهر. بين هؤلاء المستجيبين كان التقدير الإحصائي للبقاء دون حدث بعد 24 شهرا من الاستجابة 72%، بفاصل ثقة 64% إلى 79%. الحدث يشمل النكس أو التقدم أو الوفاة. [13]

كيف تقرأ هذه الأرقام؟

72% تخص المستجيبين الأوائل، وليست نسبة شفاء لكل المرضى. اختلاف 78% و80% مرتبط بمجموعة التحليل والتحديث. الدراسة أحادية الذراع ولا تثبت تفوق الدواء على استئصال جيد مع العلاج المعتاد. أغلب المشاركين أكبر عمرا؛ لا تنقل النسبة إلى شخص بعينه. [12، 13]

3. الجرعة الفورية من جيمسيتابين: SWOG S0337

في تجربة عشوائية شملت 406 مرضى، كان تقدير النكس خلال أربع سنوات 35% مع جيمسيتابين مقابل 47% مع المحلول الملحي: فرق مطلق 12 نقطة مئوية. هذه نتيجة لتقليل النكس عند إعطاء الجرعة فور العملية، وليست دليلا على فائدتها بنفس الشكل بعد أيام أو نسبة نجاة شخصية. [14]

مستجدات أخرى، وهل تنطبق عليك؟

قوة الدليل وملاءمة الحالة أهم من حداثة اسم الدواء

دورفالوماب مع BCG للحالات عالية الخطورة

وافقت FDA في 28 مايو 2026 على دورفالوماب مع BCG للبالغين ذوي سرطان مثانة غير غاز للعضلة عالي الخطورة، ممن لم يتلقوا BCG سابقا. هذا ليس خيارا روتينيا لورم Ta منخفض الدرجة ومنخفض الخطورة. [15]

في تجربة POTOMAC العشوائية من المرحلة الثالثة، شمل التقييم 1,018 مريضا. أدت إضافة دورفالوماب إلى BCGالتحريضي والصيانة إلى خفض نسبي لخطر حدث المرض عالي الخطورة أو الوفاة بنحو 32%، مقارنة بـ BCG وحده، مع نسبة مخاطر 0.68 وفاصل ثقة 0.50 إلى 0.93. [16]

لكن الأعراض الضارة المرتبطة بالعلاج من الدرجة الثالثة أو الرابعة بلغت نحو 21% مع الجمع مقابل 4% مع BCG وحده. لذلك لا يعد العلاج الأقوى أفضل تلقائيا لكل مريض، ولا تعني النتيجة إثبات فائدة مماثلة للأورام منخفضة الخطورة. [16]

نظام جيمسيتابين داخل المثانة: Inlexzo / TAR-200

وافقت FDA عليه في 9 سبتمبر 2025 لمرض غير مستجيب لـBCG مع CIS، مع أو دون أورام حليمية. في مجموعة من 83 مريضا كانت الاستجابة الكاملة في أي وقت 82%؛ استمرت 12 شهرا على الأقل لدى 51% من المستجيبين. [17]

هو نظام يبقى داخل المثانة ويطلق الدواء، وله شروط ومخاطر خاصة. لا توجد في ملفاتك معلومات تثبت وجود CIS أو فشل BCG؛ لذلك لا يمكن ترشيحه من الأوراق الحالية. تختلف مجموعته ونقطة قياس الاستجابة عن ENVISION، 17] ولا تصح مقارنة النسب مباشرة. [

علاج النكس الصغير في العيادة أو المراقبة النشطة

قد يتيح تحديث AUA 2026 لبعض المرضى أصحاب الأورام منخفضة الدرجة المتكررة تقليل العمليات تحت التخدير العام. المراقبة النشطة تعني مواعيد ومعايير واضحة للتدخل، وليست ترك المتابعة. هذا يناقش فقط بعد تأكيد التشخيص واستبعاد صفات تستدعي علاجا أقوى. [10]

ما الذي يستحق المناقشة في موعدك؟

أولا نتيجة الخزعة وفئة الخطورة؛ ثم الحاجة للعلاج داخل المثانة. إذا تأكد مرض منخفض الدرجة متكرر ومتوسط الخطورة، يمكن سؤال الطبيب عن ملاءمة Zusduri أو بدائل العيادة وتوافرها. الموافقة الأمريكية لا تثبت التوافر أو الترخيص أو التغطية المالية في العراق.

خطة المتابعة والفحوص المطلوبة

نموذج EAU 2026 يعدل وفق نتيجة الخزعة والعلاج

أول منظار مراقبة

إذا تأكد سرطان مثانة غير غاز للعضلة واستكمل العلاج بالاستئصال، يكون أول منظار عادة بعد ثلاثة أشهر. إذا اعتمد الطبيب 6 أكتوبر 2026 نقطة البداية، فالموعد التقريبي حول 6 يناير 2027؛ هذا تقدير لتنظيم المناقشة وليس حجزا أو أمرا طبيا. [3]

فئة الخطورة	المتابعة إذا كان المنظار سلبيا
منخفضة	منظار عند 3 أشهر ثم 12 شهرا من الاستئصال، وبعد ذلك سنويا حتى 5 سنوات.
متوسطة مع Ta منخفض الدرجة	منظار عند 3 أشهر، ثم كل 6 أشهر لمدة سنتين، ثم سنويا حتى 10 سنوات.
عالية أو عالية جدا	منظار وفحص خلايا البول كل 3 أشهر لمدة سنتين، ثم كل 6 أشهر حتى 5 سنوات، ثم سنويا مدى الحياة.

هذه جداول إرشادية؛ حالات الدرجة العالية ضمن الخطورة المتوسطة تتابع كنمط الخطورة العالية. أي نكس أو أعراض قد يغير الجدول. [3]

الأشعة وفحص خلايا البول

يناقش تصوير المسالك بالطبقي المحوري في حالات مختارة، مثل الورم المتعدد أو عالي الخطورة أو الموجود بالمثلث المثاني. لا توجد صور أشعة في الملفات تسمح بتقييم الكلى أو الحالبين أو العقد اللمفاوية. [1]

فحص خلايا البول أكثر فائدة للأورام عالية الدرجة؛ نتيجته السلبية لا تستبعد ورما منخفض الدرجة. الاختبارات البولية الحديثة قد تساعد في ظروف مختارة، لكن لا ينبغي إلغاء منظار مقرر دون خطة طبيب المسالك. [1، 3]

لماذا لم أحسب نسبة النكس أو التقدم؟

الحساب يحتاج المرحلة والدرجة والحجم والعدد ووجود CIS وعدد النكسات وتوقيتها والعلاج السابق. نماذج الخطورة لا تتطابق مع كل المرضى، وقد يختلف تقديرها بعد العلاج بـBCG. كلمة «منخفض الدرجة» أو العمر وحدهما لا يكفيان. [2]

النكس يعني ظهور ورم مرة أخرى. التقدم يعني انتقالا إلى صفات أخطر، مثل غزو أعمق. لا يعد طلب إعادة الاستئصال أو وجود دم بعد العملية دليلا بحد ذاته على أي منهما.

التعافي الآن وأسئلة جاهزة للطبيب

حتى موعد 13 أكتوبر 2026 الظاهر في أوراقك

رعاية ما بعد الاستئصال

قد تحدث حرقة أو زيادة مرات التبول أو دم خفيف لفترة بعد العملية. اشرب سوائل بصورة منتظمة حسب تعليمات الفريق، ما لم تكن لديك قيود بسبب القلب أو الكلى، وامش مشيا خفيفا. تجنب حمل الأثقال والمجهود الشديد حتى يسمح الجراح. ازدياد الأعراض يستدعي التواصل الطبي. [6، 18]

ورقة الخروج تتضمن باراسيتامول عند الحاجة. اتبع تعليمات طبيبك والنشرة، وتجنب جمع مستحضرات متعددة تحتوي المادة نفسها. لا تبدأ علاجا داخل المثانة أو مضادا حيويا بناء على هذا التقرير.

إذا كنت تدخن، اطلب مساعدة للإقلاع. لا تثبت الأوراق سبب الورم لديك، ولا يوجد فيها ما يبرر استبدال العلاج الطبي بحمية أو مكمل. [9]

لا تنتظر إذا حدثت مشكلة حادة

عدم التبول أو انسداد القسطرة، نزف شديد أو خثرات كبيرة، ألم شديد مستمر، أو حرارة 38 مئوية أو أكثر مع قشعريرة أو تدهور عام يستدعي تقييما عاجلا. احمل ورقة الخروج عند مراجعة الطوارئ. [6، 18]

خذ هذه الأسئلة إلى الزيارة

1. ما التشخيص الكامل في كل من الخزعتين؟ وما المرحلة والدرجة؟
2. هل عضلة المثانة موجودة وخالية من الغزو؟ وهل توجد CIS؟
3. هل سبب إعادة الاستئصال كان استكمالا للعملية، أم عينة أعمق، أم نكسا؟
4. كم كان عدد الأورام وحجم أكبرها وموقعها؟ وهل أزيلت ظاهريا بالكامل؟
5. ما فئة الخطورة، وما سبب هذا التصنيف؟
6. هل أعطيت جرعة فورية داخل المثانة؟ وإن لم تعط، هل كان هناك مانع؟
7. هل أحتاج كورس علاج داخل المثانة، وما فائدته ومخاطره وتوقيت بدئه؟
8. هل تحتاج الخزعة مراجعة اختصاصي أمراض مسالك أو تصويرا إضافيا؟
9. ما تاريخ المنظار التالي، ومتى أراجع عند ظهور دم أو أعراض بولية؟
10. إذا كان الورم منخفض الدرجة متكررا: هل تناسبني خيارات 2026 التي تقلل العمليات؟

المستندات الأهم للزيارة: خزعة الاستئصال الأول، خزعة 6 أكتوبر، تقريرا العمليتين، تقارير الأشعة إن وجدت، وسجل أي BCG أو علاج سابق داخل المثانة. لم تكن هذه البيانات متاحة عند إعداد التقرير.

المصادر ومنهج البحث

روابط أصلية قابلة للنقر؛ تاريخ الاطلاع 9 أكتوبر 2026

مراجعة مركزة للإرشادات الرسمية والدراسات الحاسمة ذات الصلة بالوصف منخفض الدرجة، مع تحديثات عالية الخطورة لتوضيح حدود انطباقها. ليست حصرا لكل دراسات سرطان المثانة أو مراجعة منهجية رسمية. روجعت الصور الأربع وعينات الفيديو محليا.

استخدمت نصوص EAU 2026 المفتوحة للتوصيات التفصيلية. بالنسبة إلى AUA 2026، أمكن التحقق من الإعلان الرسمي وملخص مقالة التحديث؛ تعذر فتح النص الكامل للإرشاد عبر أداة البحث. لم تنسب إليه تفاصيل لم تتوفر في المصادر المقروءة.

[1] EAU 2026: التشخيص، الخزعة وإعادة الاستئصال

uroweb.org - Diagnosis

[2] EAU 2026: تصنيف الخطورة والتنبؤ بالنكس والتقدم

uroweb.org - Predicting recurrence and progression

[3] EAU 2026: متابعة سرطان المثانة غير الغازي للعضلة

uroweb.org - Follow-up of patients with NMIBC

[4] NCI: ملخص علاج سرطان المثانة للمهنيين (PDQ)

cancer.gov - Bladder Cancer Treatment (PDQ)

[5] NCI: العلاج بحسب المرحلة والخطورة

cancer.gov - Treatment of Bladder Cancer by Stage

[6] Frimley Health NHS: التعافي وعلامات الخطر بعد TURBT

fhft.nhs.uk - TURBT patient information (2026)

[7] NCI: تشخيص سرطان المثانة

cancer.gov - Bladder Cancer Diagnosis

[8] NCI: مراحل سرطان المثانة

cancer.gov - Bladder Cancer Stages

[9] EAU 2026: العلاج بحسب الخطورة والسلامة

uroweb.org - Disease Management

مصادر الدراسات والتحديثات الحديثة

تمييز الدراسة المنشورة من الموافقة التنظيمية

[10] إعلان AUA الرسمي: تحديث الإرشاد في 3 سبتمبر 2026

AUA official release - 3 September 2026

AUA/SUO 2026 وزملاؤه: مقالة تحديث Clark [11]

Journal of Urology - DOI: 10.1097/JU.0000000000005280

في 12 يونيو Zusduri 2025 موافقة :FDA [12]

fda.gov - Mitomycin intravesical solution (Zusduri)

متابعة الاستجابة لمدة 24 شهرا، منشورة في 2026 :ENVISION [13]

PMID: 41880645 - DOI: 10.1097/JU.0000000000005041

العشوائية، SWOG S0337 2018 وزملاؤه: تجربة Messing [14]

JAMA - DOI: 10.1001/jama.2018.4657

موافقة 28 مايو 2026، BCG دورفالوماب مع :FDA [15]

fda.gov - Durvalumab + BCG (28 May 2026)

Lancet 2025، النهائي POTOMAC وزملاؤه: تحليل De Santis [16]

PMID: 41115436 - DOI: 10.1016/S0140-6736(25)01897-5

موافقة 9 سبتمبر Inlexzo، 2025 نظام جيمسيتابين :FDA [17]

fda.gov - Gemcitabine intravesical system (Inlexzo)

الأعراض والتعافي بعد استئصال ورم المثانة :East Kent NHS [18]

ekhuft.nhs.uk - TURBT recovery and follow-up

ما الذي سيجعل هذا التقرير أكثر تخصيصا؟

تقرير الخزعة الكامل، وخاصة المرحلة ووجود العضلة، مع وصف الورم والعلاج السابق. عند توفرها يعاد تقييم المسار المقترح ونطاق المتابعة. الأرقام الواردة من الدراسات لا تمثل توقعا شخصيا لحالتك.